PROTOCOLE DÉTAILLÉ

Conduite à tenir face à une crise d'épilepsie
Avant toute chose : RESTER CALME
Une crise d'épilepsie est impressionnante mais elle s'arrête généralement d'elle-même en quelques minutes. Votre rôle est de protéger et surveiller, pas d'intervenir médicalement.

PHASE 1 : PENDANT LA CRISE TONICOCLONIQUE (convulsions)

À FAIREÀ NE PAS FAIRE

✅ PROTÉGER : Éloignez les meubles, chaises, tables pour éviter les blessures.
❌ NE RIEN METTRE DANS LA BOUCHE : ni doigts, ni stylo, ni trousse, ni mouchoir. C'est dangereux et inutile.
✅ GLISSER UN VÊTEMENT sous sa tête (veste, pull, sac souple).
❌ NE PAS CONTENIR les mouvements. Ne pas lui tenir les bras ou les jambes.
✅ DESSERRER sa cravate, écharpe ou col (si serré).
❌ NE PAS DONNER À BOIRE pendant la crise.
✅ CHRONOMÉTRER : notez l'heure exacte du début de la crise.
❌ NE PAS LE DÉPLACER sauf danger immédiat (route, escalier).

PHASE 2 : APRÈS LA CRISE (phase post-critique)

1. POSITION LATÉRALE DE SÉCURITÉ (PLS) : Dès que les secousses s'arrêtent, tournez doucement l'élève sur le côté. Cela permet d'éviter qu'il s'étouffe avec sa salive ou sa langue (qui ne peut pas être avalée, mais peut tomber en arrière).
2. Comment faire la PLS :
   - Mettez l'élève sur le côté
   - Tête légèrement inclinée vers l'arrière
   - Bouche ouverte vers le bas
3. RASSURER : À son réveil (après quelques minutes), l'élève sera confus, fatigué, parfois agité. Parlez-lui calmement :
   - "Tu es en sécurité, tu as fait une crise, c'est fini maintenant."
   - "Ne te lève pas tout de suite, repose-toi."
4. NETTOYER : Si l'élève a uriné ou salivé, protégez sa pudeur en attendant les secours ou l'infirmière.
5. INFORMER : Prévenez immédiatement la direction et la famille.

PHASE 3 : APRÈS LA CRISE (cas des absences ou crises focales)

- Absence : L'élève reprend son activité sans s'en rendre compte. Pas besoin de soins particuliers. Rassurez-le discrètement. Vérifiez qu'il a bien compris la consigne suivante.
- Crise focale : Restez avec lui. Parlez calmement. Ne le grondez pas. Proposez-lui d'aller à l'infirmerie s'il se sent fatigué.

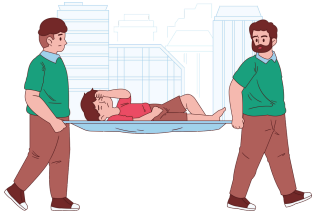
"Être prêt, c'est déjà protéger."

Contacts d'urgence locaux et ressources
NUMÉROS D'URGENCE NATIONAUX (TUNISIE)

NUMÉROS D'URGENCE NATIONAUX (TUNISIE)

- SAMU (Urgences médicales) : 190 – Appel gratuit, disponible 24h/24
- Protection Civile (Ambulances) : 198 – Urgences, insister en cas de lignes encombrées
- Police Secours : 197 – Si besoin de sécuriser les lieux
- SOS Ambulances : 71 725 555 / 71 599 900 – Ambulances privées
- Ambulances médicalisées : 71 780 000 / 71 781 000 – Transport médicalisé

Ces numéros doivent être :



- ✓ Affichés en salle des professeurs
- ✓ Affichés à l'administration
- ✓ Enregistrés dans le téléphone de l'établissement

En cas de crise à l'école :

- Appliquer les gestes de premiers secours (page 1).
- Appeler le 190 ou le 198 si nécessaire .
- Prévenir la direction de l'établissement.
- Contacter la famille immédiatement.
- Rapporter l'incident par écrit (cahier de liaison, rapport à la direction).
- Transmettre les observations au médecin scolaire.
- Important : Pour la mise en place d'un Projet d'Accueil Individualisé (PAI), contactez le médecin scolaire de votre circonscription.

RAPPEL : CE QU'IL FAUT AVOIR DANS LA CLASSE

- Liste des numéros d'urgence affichée près du téléphone
- Fiche gestes d'urgence visible
- Coordonnées des parents à jour
- Trousse de secours accessible
- Oreiller ou vêtement pour protéger la tête (dans un placard)

Organisation interne de l'établissement

Chaque élève diagnostiqué épileptique devrait avoir :

- Un protocole médical écrit
- Une autorisation parentale
- Les coordonnées des parents ou tuteurs
- L'indication d'un éventuel traitement d'urgence
- L'équipe éducative doit savoir :
- Où se trouve le dossier médical
- Qui est responsable d'administrer un traitement si prescrit
- Qui contacte les parent

Accompagnement et suivi

La phase post-crise est essentielle. Elle détermine le bien-être de l'élève et son retour serein en classe.

Après une crise, l'élève peut :

- Être désorienté et confus
- Avoir mal à la tête
- Être très fatigué, parfois épuisé
- Ne pas se souvenir de ce qui s'est passé
- Avoir envie de dormir
- Parfois être agité ou irritable

1. Attitude immédiate à adopter

Ce qu'il faut faire :

- Parler doucement et calmement à l'élève
- Le rassurer : "C'est fini, tu es en sécurité"
- Lui dire où il est et ce qui s'est passé simplement
- Éviter les attroupements autour de lui
- Laisser le temps de récupération nécessaire
- Respecter sa dignité, surtout s'il a uriné ou salivé
- Proposer de l'accompagner à l'infirmerie

2. Retour en classe

- Le retour en classe se fait en fonction de l'état de l'élève, jamais de manière forcée.
- Plusieurs possibilités selon son état :
- Repos à l'infirmerie pendant 30 minutes à 1 heure
- Retour progressif en classe avec une activité légère
- Demi-journée de repos avec retour à la maison si la fatigue est trop importante
- Récupération complète et retour normal le lendemain

3. Communication et suivi

- Qui doit être informé ?
- La direction de l'établissement
- L'infirmerie scolaire
- Les parents (appel téléphonique immédiat)
- L'équipe pédagogique (de manière discrète et professionnelle)

Que noter dans le registre ?

- La date et l'heure de la crise
- La durée de la crise
- Le déroulement observé
- Les gestes effectués
- L'état de l'élève après la crise
- Les personnes informées